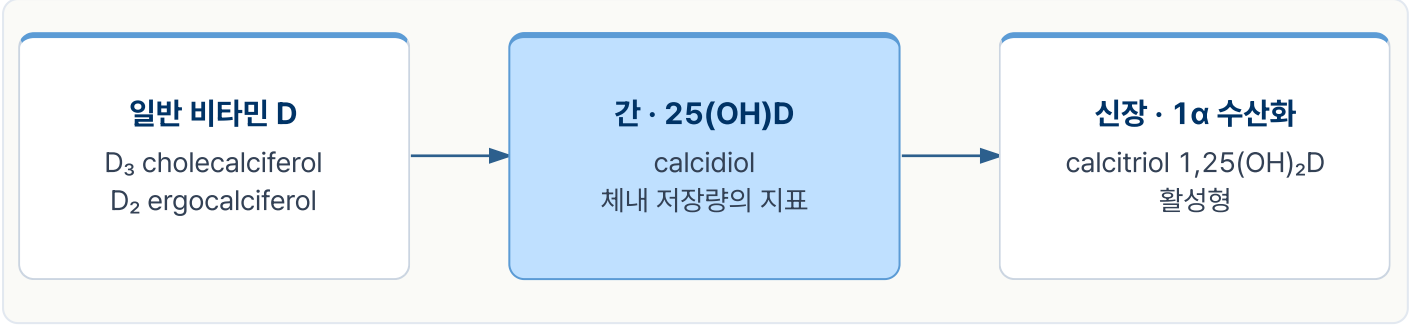
의료진 진료 카드 · ASL-056

칼슘·비타민 D · 목적과 제형

골다공증 보충, 부갑상선기능장애 치료, 단순 영양 보충을 구분한다. 강의·연자 Q&A 기준.

저장 지표와 활성형을 구분한다



치료 목적에 맞춘 선택

칼슘+일반 D	장 칼슘 흡수에 비타민 D가 필요. 수동 흡수 약 5%, 비타민 D 관련 능동 흡수 20~70%로 소개. D 부족 → 흡수 감소 → 혈중 Ca 감소 → PTH 증가 → 골흡수 증가.
활성형 · 연자 Q&A	신기능 정상이면 일반 D(cholecalciferol) 우선. 활성형은 25(OH)D 저장량을 채우지 않고 고칼슘혈증·고칼슘뇨·신결석·신기능 저하 위험이 있어 특별한 상황 외 무기한 복용을 권하지 않는다고 답변.
부갑상선기능저하 · 연자 Q&A	갑상선전절제술 등 후 부갑상선기능장애는 골밀도와 무관한 별도 급여 항목. 연자는 칼슘+calcitriol 또는 alfacalcidol(본키) 등 활성형이 기전상 맞는다고 답변.

칼슘·D 복합경구제 · 급여 구분

강의 제시 일반원칙	2026-02-01 시행 내용으로 골다공증치료제 일반원칙 급여대상(전액본인부담 포함) 또는 갑상선절제술 등 부갑상선기능장애 투여 시 급여, 이외 전액 환자 부담으로 설명.
본원 팝업 사례	골다공증 치료: 최근 1년 이내 골밀도 결과 + T≤−1.0이면 급여, T>−1.0이면 전액본인부담으로 제시. 단순 예방·육체피로·체력저하는 비급여.
연자 Q&A	골감소증도 1년 이내 T≤−1.0이면 칼슘+D 복합제 급여 가능하다고 답변. 이 팝업 조건을 부갑상선기능장애의 공통 필수조건으로 적용하지 않는다.

칼슘은 음식으로 먼저 채운다는 교재 설명: 하루 800~1,000mg, 식이 부족 시 보충제 고려. 연자 Q&A에서는 데노수맙 치료 시 음식 또는 약으로 비타민 D와 함께 칼슘을 보충해야 한다고 강조했다.

의료진 진료 카드 · ASL-056

비타민 D · 목표와 재검

혈중 농도 목표와 보충량, 검사 산정횟수, 연자의 실제 시작·중단 기준을 따로 읽는다.

25(OH)D · 본강의 목표

농도 구간	ng/mL: 중증 결핍 <10, 결핍 10~20, 불충분 20~30, 적정 30~50. 골다공증 예방 ≥20, 치료·골절 예방 ≥30; ≥50은 잠재적 위해로 소개.
보충량	최소 800 IU/일. 교재 대안 D_3 5,600 IU/주 또는 24,000 IU/월. 800 IU/일은 3개월에 8~13 ng/mL, 100 IU/일은 1~1.6 ng/mL 상승으로 제시.
실전 예	기저 25(OH)D 9 ng/mL → 30 가까이 목표: cholecalciferol 2,000 IU/일을 2~3개월 사용하면 평균 약 20 상승한다는 강의 예. 개인별 반응은 재검으로 평가.
D 검사 급여	약물 투여 전 1회, 투여 3~6개월 후 1회, 이후 추적 연 2회까지 인정으로 소개. 저장량 평가는 25(OH)D를 측정.

연자 Q&A · 약제 시작과 고농도

첫 데노수맙	Vit D 10·Ca 8.9 질문: 연자는 첫 투여 저칼슘혈증을 피하기 위해 개인적으로 25(OH)D를 최소 20 이상으로 올리고 시작한다고 답변. 골다공증 치료 목표 30~50과 별개의 시작 관행.
≥50 ng/mL	연자는 추가 골 이득이 없고 낙상·심혈관 사건 등 위해 가능성을 이유로 칼슘+D 복합제를 중단하고, 추적에서 <50이면 다시 투여한다고 답변.
석회화·요로결석 질문	연자는 칼슘 섭취가 높은 국가의 고용량 보충 연구를 국내에 그대로 적용하지 않으며, 데노수맙 시 음식 또는 약으로 칼슘·D를 보충해야 한다고 답변.

처방 전에 구분할 세 축

무엇을 치료하는가

골다공증·부갑상선기능장애·단순 예방 목적을 구분해 급여 경로를 선택한다.

무슨 D인가

cholecalciferol 등 일반형과 calcitriol·alfacalcidol 등 활성형을 구분한다.

어느 수치인가

25(OH)D 저장량과 활성형 작용, 혈중 칼슘·신기능 위험을 같은 값으로 취급하지 않는다.

언제 다시 보는가

투여 전 → 3~6개월 후 → 이후 연 2회라는 강의의 검사 일정과 약제별 일정을 함께 관리한다.